

NEUROSURV

Surveillance van neurologische infectieziekten in België

Jaarverslag 2025

April 2026

G. STEFANI • T. LERNOUT

DANKWOORD

De dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano wil graag alle deelnemende artsen die bijdragen aan NeuroSurv, evenals de leden van de stuurgroep, bedanken voor hun waardevolle bijdrage.

Met financiële steun van



Gelieve deze publicatie als volgt te citeren: Stefani G, Lernout T. Surveillance van neurologische infectieziekten in België. Jaarverslag 2025. Brussel, België: Sciensano; 2026. Rapportnummer D/2026.14.440/43

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Methode	5
3. Resultaten	6
3.1. Deelname	6
3.2. Lyme neuroborreliose	8
3.3. Tekenencefalitis	11
3.4. Acute slappe verlamming	11
Discussie	12
Referenties	13
Bijlage 1 – Gevalsdefinities	14

1. Inleiding

Surveillance van infectieziekten in België gebeurt via verschillende systemen, zoals de verplichte melding, surveillance door laboratoria (Nationale Referentiecentra en het peilnetwerk van laboratoria) en via een netwerk van huisartsenpeilpraktijken.

Sedert 2019 is het rapporteren van gevallen van Lyme neuroborreliose (LNB) verplicht in Europa, gebaseerd op een EU-gevalsdefinitie (Bijlage 1). België kon toen echter niet voldoen aan de rapporteringsverplichting op Europees niveau, bij gebrek aan een geschikt surveillancesysteem.

Daarom werd in januari 2024 een surveillancesysteem voor neurologische infectieziekten, NeuroSurv, opgezet op basis van vrijwillige deelname van neurologen en kinderneurologen. Het netwerk maakt het mogelijk om geaggregeerde gegevens over LNB te verzamelen en deze te rapporteren aan het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Naast LNB laat het netwerk toe om gegevens te verzamelen over andere neurologische infecties, waarvan de bestaande surveillance de reële ziektelast mogelijk onderschat. Zo werden in 2024 en 2025 ook gegevens verzameld over tekenencefalitis (TBE) en acute slappe verlamming (AFP). In de toekomst kan dit worden uitgebreid naar andere neurologische infectieziekten of syndromen.

Lyme neuroborreliose (LNB)

LNB is de enige manifestatie van Lyme borreliose (LB) met een duidelijke gevalsdefinitie die homogeen kan worden toegepast in de lidstaten van de Europese Unie (EU). Bovendien is het verwachte aantal jaarlijkse gevallen laag genoeg om een exhaustieve surveillance mogelijk te maken (in tegenstelling tot erythema migrans, de meest frequente manifestatie van LB). Het ECDC heeft in 2019 de surveillance van LNB opgestart, als manier om de ziektelast van LB in Europa te beoordelen en om een vergelijking tussen EU-landen en regio's toe te laten (1,2).

De diagnose van LNB is gebaseerd op klinische symptomen en laboratoriumanalyses op serum en cerebrospinaal vocht (CSV). Daarom moeten gegevens van de behandelende arts, het algemene laboratorium (pleiocytose) en het microbiologische laboratorium worden gecombineerd (3–5). Mede door deze complexiteit bij het diagnosticeren van LNB waren de bestaande surveillancenetwerken niet in staat om het aantal LNB-gevallen in België in te schatten en op te volgen. Surveillance van LB wordt wel uitgevoerd via andere surveillancesystemen en studies. Zo schatte een studie op basis van de LB-gegevens voor de periode 2015-2017 de incidentie van LNB in België op 2,4/100.000 inwoners (95% UI 1,5-3,7), wat overeenkomt met ongeveer 270 LNB-gevallen per jaar (6). Meer informatie over de meest recente gegevens over Lyme borreliose is [hier](#) beschikbaar.

Tekenencefalitis (TBE)

TBE wordt in Europa beschouwd als een opkomende ziekte vanwege de stijgende incidentie en de uitbreiding naar nieuwe, voorheen niet-geïnfecteerde gebieden (7). In België is de surveillance van TBE bij mensen gebaseerd op de melding van bevestigde gevallen door het Nationaal Referentiecentrum (NRC) in het Instituut voor Tropische Geneeskunde. In 2025 werd TBE ook toegevoegd aan de lijst van verplicht te melden ziekten in Vlaanderen. De eerste twee waarschijnlijk autochtone gevallen van de ziekte werden gemeld in 2018, en in 2020 waren er drie gevallen die met zekerheid in België werden besmet (8,9). Er wordt echter een onderdiagnose van humane gevallen vermoed, omdat milde infecties waarschijnlijk niet gediagnosticeerd worden en laboratoriumonderzoek bij virale encefalitis over het algemeen beperkt is. Seroprevalentiestudies bij dieren hebben aangetoond dat het virus al vele jaren circuleert in België. Afhankelijk van het dier en de studieperiode zijn verschillende prevalentiecijfers gerapporteerd, variërend van 0,11% bij honden in 2009 (België) tot 9,27% bij everzwijnen in 2019/2020 (Vlaanderen) (10–12).

Naast surveillance via studies bij dieren, werd verwacht dat het verbeteren van de surveillance van TBE bij mensen door neurologen via NeuroSurv (met oa een toenemende alertheid voor de ziekte) zou helpen om het

risico op TBE bij mensen in België beter te begrijpen en in te schatten. Meer informatie over de meest recente gegevens over TBE is [hier](#) beschikbaar.

Acute slappe verlamming (AFP)

Hoewel het poliovirus in België is uitgeroeid sinds 2002, wordt het risico op herintroductie door de Wereld gezondheidsorganisatie (WGO) beoordeeld als "gemiddeld", voornamelijk als gevolg van onvoldoende surveillance.

Polio is een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (Public health emergency of international concern, PHEIC) vanwege het toegenomen aantal gevallen van circulerend vaccin-afgeleid poliovirus (cVDPV) in de afgelopen jaren, vooral in gebieden die voorheen als "poliovrij" werden beschouwd.

De surveillance voor poliovirus in België is gebaseerd op de surveillance van AFP-gevallen, aangevuld met surveillance van afvalwater en enterovirussen. Alle AFP-gevallen bij personen jonger dan 15 jaar, ongeacht de oorzaak, moeten verplicht gemeld worden. Laboratoriumanalyse (twee stoelgangsstalen met een interval van >24 uur die naar het NRC voor enterovirus in het UZLeuven moeten worden gestuurd) is vereist om te bevestigen dat het AFP-geval niet door poliovirus werd veroorzaakt. Indien de surveillance alle gevallen van AFP zou registreren, zouden ongeveer 19 gevallen per jaar gemeld moeten worden in België - wat overeenkomt met 1 geval per 100.000 kinderen onder de 15 jaar. België is er echter sinds het begin van de surveillance niet in geslaagd om dit doel te bereiken. Het verbeteren van de AFP-surveillance in België en een verhoogde kennis bij klinici over de meldingsplicht zijn essentieel. Vooral kinderneurologen hebben een grotere kans om AFP-gevallen tegen te komen bij kinderen jonger dan 15 jaar. Meer informatie over de meest recente gegevens over de surveillance van poliovirus is [hier](#) beschikbaar.

2. Methode

Eind 2023 werden alle afdelingen voor neurologie en kinderneurologie van de ziekenhuizen in de drie Belgische gewesten per e-mail en/of telefonisch uitgenodigd om deel te nemen aan NeuroSurv, met het verzoek om een deelnemer voor te stellen als vertegenwoordiger van de hele afdeling. In 2024 en 2025 werd opnieuw contact opgenomen met alle afdelingen om de deelname te verhogen en nieuwe deelnemers te werven.

Elke maand ontvangen de geregistreerde deelnemers een link naar een vragenlijst in LimeSurvey, waarmee geaggregeerde gegevens kunnen worden doorgegeven over de ziekten die in de surveillance zijn opgenomen. Als er de afgelopen maand geen enkel geval te melden was, moet dit ook gerapporteerd worden ("nulmelding").

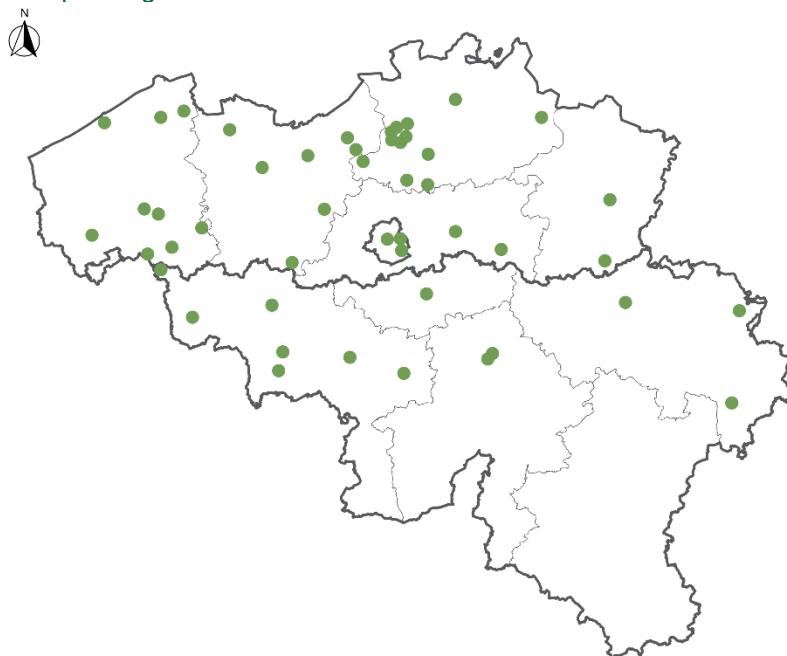
De lijst van ziekten onder surveillance wordt jaarlijks herzien door een stuurgroep van het netwerk, samengesteld uit vertegenwoordigers van de regionale gezondheidsautoriteiten, neurologen, kinderneurologen, infectiologen en epidemiologen van Sciensano.

3. Resultaten

3.1. Deelname

Het aantal deelnemende artsen is in de loop van 2025 toegenomen van 48 in januari tot 51 in oktober. De 51 deelnemers vertegenwoordigden 48 verschillende ziekenhuizen¹, op een totaal van 121 gecontacteerde ziekenhuizen (40%), verspreid over de drie gewesten (30 ziekenhuizen in Vlaanderen, 15 in Wallonië en drie in Brussel). Zoals te zien is in Figuur 1, zijn er minder deelnemende ziekenhuizen in het zuiden van België, waar ook minder ziekenhuizen zijn².

Figuur 1: Geografische spreiding van de ziekenhuizen die deelnemen aan NeuroSurv



In 2025 werden in totaal 278 volledige deelnames geregistreerd op 599 verzonden maandelijkse uitnodigingen, wat overeenkomt met een globale deelname van 46%. Het aantal deelnemende artsen per maand, die ten minste één geval of nul gevallen rapporteerden, varieerde van 6 (in september en december) tot 30 (in januari), met een gemiddelde van 23 (Figuur 2). Dit is iets lager dan de gemiddelde deelname in 2024 (26 per maand), ondanks een hoger aantal geregistreerde deelnemers.

Van de 278 deelnames die in 2025 werden geregistreerd, ging het voor 244 (88%) om een melding van 'nul gevallen' (Figuur 2).

¹ Een ziekenhuis kan verschillende deelnemers omvatten, afkomstig van verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis (bijvoorbeeld neurologie en kinderneurologie) of van verschillende locaties van éénzelfde instelling.

² [Lijst met gezondheidsinstellingen in België.](#)

Figuur 2: Aantal deelnemers per maand (melding van 'nul gevallen' of ten minste één geval), 2025

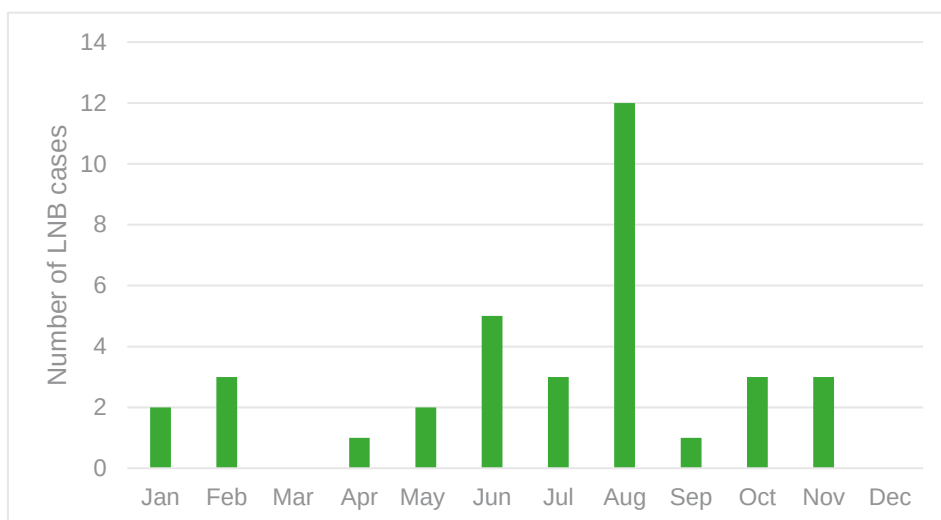


3.2. Lyme neuroborreliose

In 2025 werden 35 gevallen van LNB gemeld door 17 verschillende deelnemers verspreid over het hele land (vier in Wallonië, 11 in Vlaanderen en twee in Brussel).

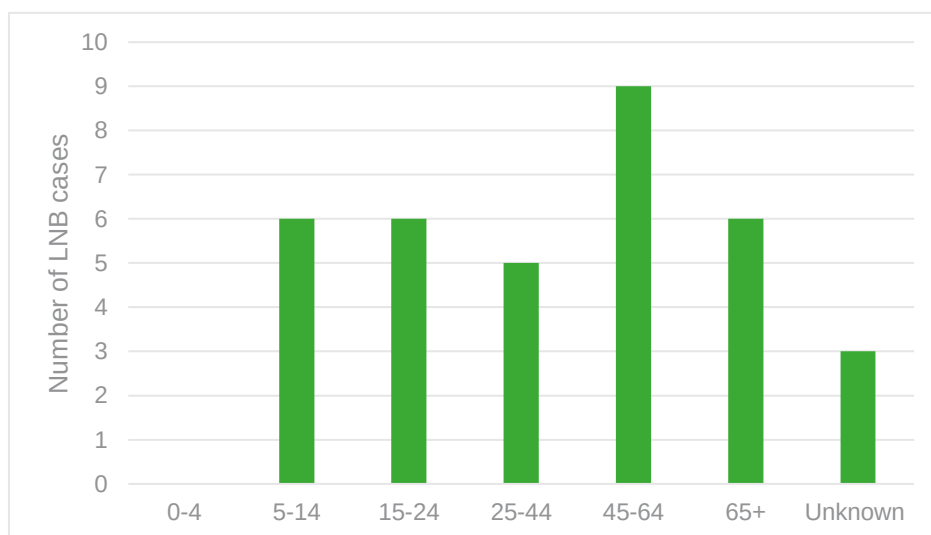
Er werden het hele jaar door gevallen gemeld met een piek tijdens de zomermaanden, vooral in augustus (n=12) (Figuur 3). Deze seizoensgebonden spreiding kan verband houden met het grotere risico op tekenbeten tijdens de lente en zomer, hoewel LNB zich weken tot maanden na een tekenbeet kan manifesteren en dus niet noodzakelijkerwijs optreedt tijdens het seizoen waarin de meeste tekenbeten worden opgelopen (13).

Figuur 3: Aantal gemelde gevallen van LNB per maand, 2025



Het hoogste aantal gevallen werd geregistreerd in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar (n=9) (Figuur 4). In totaal was 43% van de gevallen (n=15) in 2025 45 jaar of ouder. Meer dan de helft van de gevallen betrof mannen (n=21, 60%).

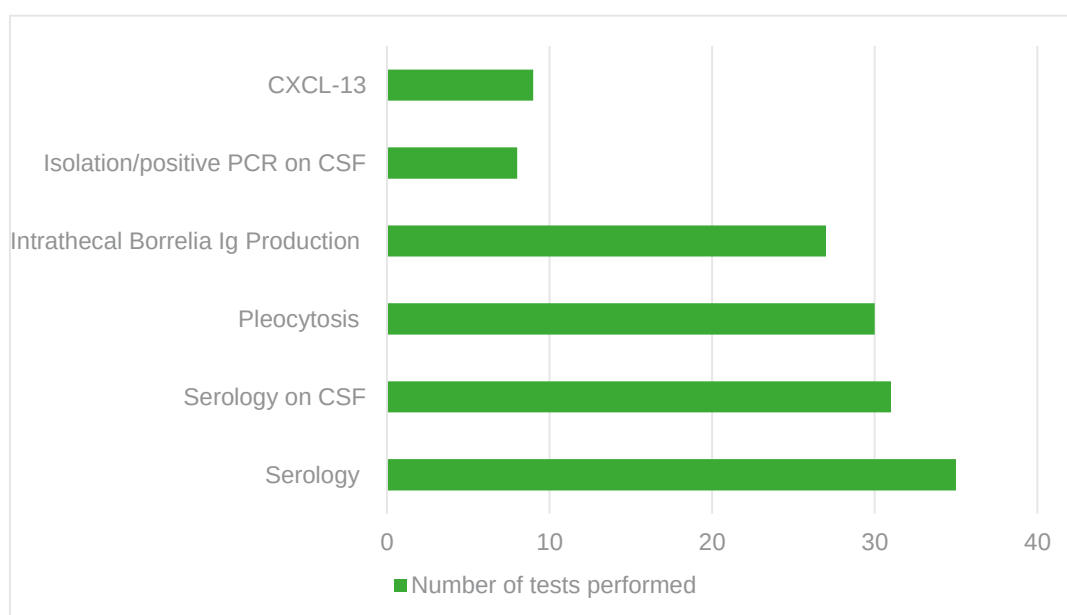
Figuur 4: Aantal gemelde gevallen van LNB per leeftijdsgroep, 2025



Voor de diagnose werden verschillende testmethoden gebruikt (Figuur 5). Volgens de gevaldefinitie van de EU moet er voor een bevestigd of waarschijnlijk geval steeds een lumbaalpunctie uitgevoerd worden, om zowel een pleiocytose als een intrathecale productie van *Borrelia*-antistoffen aan te tonen (waarbij er dus zowel een serologische test op bloed als op CSV uitgevoerd moet worden). In tegenstelling tot 2024 kon er in 2025 op basis van de verzamelde gegevens een onderscheid gemaakt worden tussen de aanvraag van een onderzoek en het resultaat ervan.

In 2025 werd bij 31 van de 35 gerapporteerde gevallen (89%) een lumbaalpunctie uitgevoerd; pleiocytose werd bevestigd bij 28 patiënten, terwijl intrathecale antilichaamproductie werd aangetoond bij 22 patiënten³. CXCL13, gebruikt als aanvulling op serologie in de diagnostiek van LNB, werd getest bij negen patiënten, van wie er zes positief bleken te zijn. Op basis hiervan werden 27 van de 35 gevallen (77%) weerhouden als waarschijnlijk of bevestigd geval, volgens de gevaldefinitiecriteria van het ECDC (Bijlage 1).

Figuur 5: Type diagnostische tests gebruikt voor LNB, 2025³



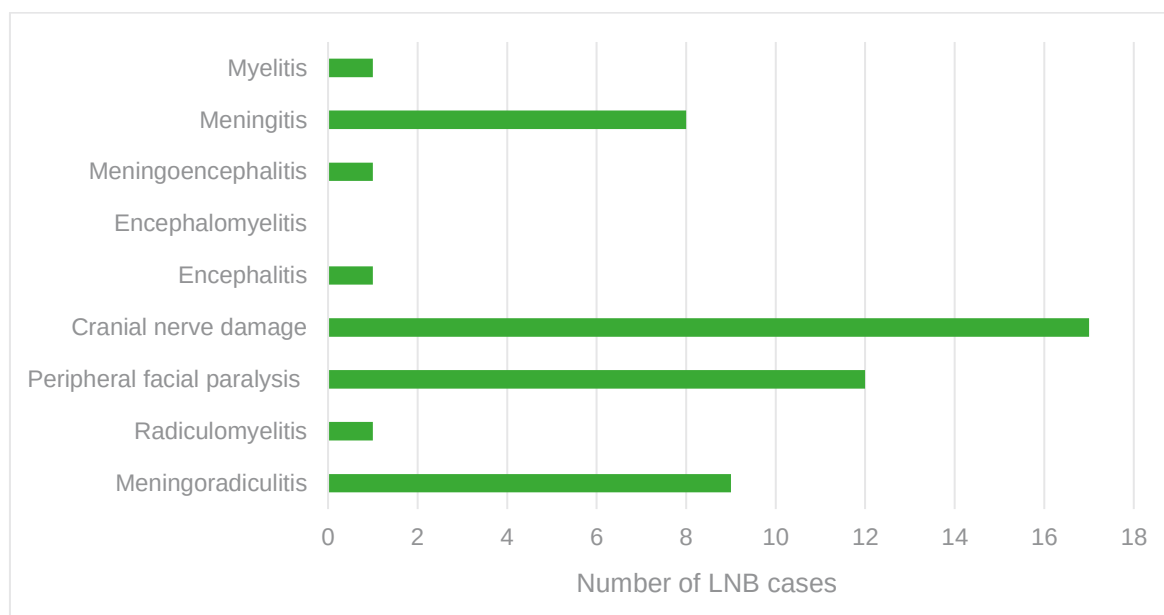
Voor zes patiënten (17%) was er een aantasting van het centrale zenuwstelsel (CZS), voor 18 (51%) van het perifere zenuwstelsel (PZS) en voor 11 (31%) ging het om een combinatie van beide. De meest voorkomende klinische manifestatie was aantasting van de craniale zenuwen (n=17), gevolgd door een facialis paralyse (n=12) (Figuur 6).

Eenentwintig gevallen (60%) kregen een intraveneuze antibiotica behandeling, vier gevallen (11%) kregen een orale behandeling en zeven gevallen (20%) kregen een combinatie van beide. Voor drie gevallen was de informatie niet bekend.

Negenentwintig patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis (83%) en één patiënt werd op de dienst intensieve zorgen opgenomen. Er zijn geen patiënten overleden.

³ Er kunnen meerdere tests zijn uitgevoerd bij dezelfde patiënt.

Figuur 6: Gerapporteerde klinische manifestaties bij LNB, 2025⁴



⁴ Bij eenzelfde patiënt kunnen meerdere klinische manifestaties zijn vastgesteld.

3.3. Tekenencefalitis

In 2025 werden er drie gevallen van TBE gemeld, één door een ziekenhuis in Wallonië, één in Brussel en één in Vlaanderen. Het betrof twee vrouwen in de leeftijdsgroep 25-44 jaar en een man ouder dan 65 jaar. Twee patiënten raakten besmet na een tekenbeet in het Zwarte Woud (Duitsland). De derde patiënt raakte besmet via voedsel in Frankrijk. De drie patiënten werden gehospitaliseerd zonder opname op de dienst intensieve zorgen, en geen van hen is overleden. De drie gevallen werden ook gemeld door het Nationaal Referentiecentrum (Instituut voor Tropische Geneeskunde).

3.4. Acute slappe verlamming

In 2025 werden vier gevallen van AFP gemeld door drie verschillende ziekenhuizen, verspreid over de drie regio's. De gevallen werden gemeld in januari, februari, april en juni. Slechts twee gevallen (50%) waren jonger dan 15 jaar (een jongen en een meisje). Er werd geen diagnostisch laboratoriumonderzoek uitgevoerd om poliomyelitis uit te sluiten (twee stoelgangsstalen afgenomen met een interval van 24 uur), zoals aanbevolen. Eén geval werd gemeld aan de regionale autoriteit (via de verplichte melding), terwijl voor het andere geval deze informatie onbekend was.

Discussie

Dit jaarverslag presenteert de resultaten van het tweede jaar van de surveillance van neurologische infectieziekten door het netwerk NeuroSurv in België. Na een nieuwe sensibilisatie van neurologen via een nieuwe email naar alle ziekenhuizen met een afdeling neurologie en kinderneurologie en een presentatie van het netwerk tijdens conferenties, hebben drie bijkomende ziekenhuizen toegezegd om in 2025 deel te nemen, met een huidig totaal van 51 deelnemende artsen. Het totaal aantal maandelijks deelnemende artsen (46%) lag echter lager dan in 2024 (55%), met gemiddeld 23 deelnemers per maand. Dit is vooral te wijten aan een zeer lage deelname in de maanden september en december, zonder specifieke verklaring.

Ondanks een lagere algemene deelname werden er in 2025 meer gevallen van Lyme neuroborreliose (LNB) gemeld, met 35 gevallen tegenover 25 gevallen in 2024. De preliminaire gegevens⁵ van andere bronnen voor de surveillance van Lyme borreliose, zoals het netwerk van huisartsenpeilpraktijken, wijzen ook op een hoger aantal gevallen in 2025 in vergelijking met voorgaande jaren. Dit komt overeen met de resultaten van de surveillance van tekenbeten via TekenNet in het voorbije jaar, waarbij het aantal gemelde beten hoger lag dan het gemiddelde van de periode 2022-2024, maar eerder vergelijkbaar was met de jaren voordien (13).

Van de 35 gevallen van LNB voldeden er 27 (77%) aan de criteria van de definitie van een waarschijnlijk of bevestigd geval om aan het ECDC te worden gemeld. Dit is een stijging ten opzichte van het percentage in 2024 (60%). Aangezien het om kleine aantallen en over slechts twee jaren gaat, moet de vergelijking met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, maar dit zou erop kunnen wijzen dat de deelnemende artsen de aanbevelingen voor de diagnose van LNB beter naleven. Het aantal gemelde gevallen blijft echter een aanzienlijke onderschatting van de werkelijke verwachte ziektelast van LNB in België, in vergelijking met de jaarlijkse schatting van 270 gevallen (6), wat te wijten is aan verschillende factoren (niet exhaustief netwerk, lage en/of onregelmatige maandelijkse deelname, niet alle gevallen van LNB worden gediagnosticeerd door een neuroloog of een kinderneuroloog,...).

Naast de gevallen van LNB werden er ook drie gevallen van TBE en vier gevallen van AFP gemeld, vergeleken met respectievelijk 1 geval en 10 gevallen in 2024. De voorlopige gegevens⁵ voor TBE in 2025 laten eveneens een hoger aantal geregistreerde gevallen zien via de andere surveillancebronnen (NRC voor arbovirussen en meldingsplicht in Vlaanderen), zowel voor geïmporteerde als autochtone gevallen. Dit komt ook overeen met een hoger aantal tekenbeten in dat jaar (zie hoger). Voor AFP was het aantal gemelde gevallen in 2025 ook opnieuw beperkt en lager dan het aantal gevallen dat in het kader van de meldingsplicht werd geregistreerd (n=6 bij kinderen < 15 jaar).

Ondanks enkele beperkingen heeft NeuroSurv het voor het tweede opeenvolgende jaar mogelijk gemaakt om gegevens over LNB in België door te geven aan ECDC (wat een Europese verplichting is) en artsen meer te betrekken bij de surveillance van infectieziekten in België. Het doel is om het netwerk verder te versterken en de kwaliteit van de gegevens verder te verbeteren.

Vanaf 2026 zal de gegevensverzameling voor LNB evolueren van een geaggregeerde rapportage naar een verzameling van individuele gegevens. Dit zal een vollediger rapportering van de gegevens aan ECDC mogelijk maken. Om de werklast voor de deelnemende artsen te beperken, werd besloten de surveillance te beperken tot LNB en de gegevensverzameling over TBE en AFP enkel voort te zetten via de andere bestaande surveillancesystemen. Afhankelijk van de epidemiologische situatie kunnen echter in de toekomst ook andere relevante ziekten aan de surveillance worden toegevoegd. Zo zou, in de context van een circulatie van het West-Nijlvirus (WNV) bij vogels in België, die eind augustus 2025 voor het eerst werd aangetoond (14), een versterkte surveillance van de ziekte via NeuroSurv relevant kunnen zijn. Dit wordt momenteel besproken in het kader van de uitwerking van een nationaal WNV-paraatheidsplan in België.

⁵ Rapport in opstelling.

Referenties

1. van den Wijngaard CC, Hofhuis A, Simões M, Rood E, van Pelt W, Zeller H, et al. Surveillance perspective on Lyme borreliosis across the European Union and European Economic Area. *Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull.* 6 Jul 2017;22(27):30569.
2. Burn L, Vyse A, Pilz A, Tran TMP, Fletcher MA, Angulo FJ, et al. Incidence of Lyme Borreliosis in Europe: A Systematic Review (2005-2020). *Vector Borne Zoonotic Dis Larchmt N.* Apr 2023;23(4):172-94.
3. BAPCOC. Lyme-borreliose (Borrelia-infectie). Beschikbaar via: https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/guide_borreliose_de_lyme_fr_2024_0.pdf
4. Figoni J, Chirouze C, Hansmann Y, Lemogne C, Hentgen V, Saunier A, et al. Lyme borreliosis and other tick-borne diseases. Guidelines from the French Scientific Societies (I): prevention, epidemiology, diagnosis. *Med Mal Infect.* Aug 2019;49(5):318-34.
5. Dahl V, Wisell KT, Giske CG, Tegnell A, Wallensten A. Lyme neuroborreliosis epidemiology in Sweden 2010 to 2014: clinical microbiology laboratories are a better data source than the hospital discharge diagnosis register. *Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull.* 2019;24(20):1800453.
6. Geebelen L, Van Cauteren D, Devleeschauwer B, Moreels S, Tersago K, Van Oyen H, et al. Combining primary care surveillance and a meta-analysis to estimate the incidence of the clinical manifestations of Lyme borreliosis in Belgium, 2015-2017. *Ticks Tick-Borne Dis.* Apr 2019;10(3):598-605.
7. Van Heuverswyn J, Hallmaier-Wacker LK, Beauté J, Gomes Dias J, Haussig JM, Busch K, et al. Spatiotemporal spread of tick-borne encephalitis in the EU/EEA, 2012 to 2020. *Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull.* 2023;28(11):2200543.
8. Lernout. sciensano.be. Epidemiologische surveillance van door teken overgedragen encefalitis - 2018. Beschikbaar via: <https://www.sciensano.be/fr/biblio/surveillance-epidemiologique-de-lencephalite-a-tiques-2018>
9. Stoefs A, Heyndrickx L, De Winter J, Coeckelbergh E, Willekens B, Alonso-Jiménez A, et al. Autochthonous Cases of Tick-Borne Encephalitis, Belgium, 2020. *Emerg Infect Dis.* Aug 2021;27(8):2179-82.
10. Linden A, Wirtgen M, Nahayo A, Heyman P, Niedrig M, Schulze Y. Tickborne encephalitis virus antibodies in wild cervids in Belgium. *Vet Rec.* Jan 2012;170(4):108.
11. Roelandt S, Suin V, Riocreux F, Lamoral S, Van der Heyden S, Van der Stede Y, et al. Autochthonous tick-borne encephalitis virus-seropositive cattle in Belgium: a risk-based targeted serological survey. *Vector Borne Zoonotic Dis Larchmt N.* Sept 2014;14(9):640-7.
12. Adjadj NR, Vervaeke M, Sohler C, Cargnel M, De Regge N. Tick-Borne Encephalitis Virus Prevalence in Sheep, Wild Boar and Ticks in Belgium. *Viruses.* 26 Oct 2022;14(11):2362.
13. Geebelen L, Lernout T. Tekennet. Surveillance van tekenbeten in België. Resultaten in 2025. Beschikbaar via: https://www.sciensano.be/sites/default/files/surveillance_van_tekenbeten_tekennet_2025_final.pdf
14. Sohler C, Breman FC, Vervaeke M, Sikkema R, Boter M, Oude Munnink B et al. First detection of West Nile virus in Belgium through wild bird surveillance, Belgium, 2025. *Euro Surveill.* 2026 Jan;31(4):2600049.

Bijlage 1 – Gevalsdefinities

Lyme neuroborreliose

Bron: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/ 945 - of 22 June 2018 - on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant case definitions (europa.eu)

3.25. LYME NEUROBORRELIOSIS

Clinical Criteria

- Neurological symptoms according to European Federation of Neurological Societies (EFNS) suggested case definition (¹), without other obvious reasons

Laboratory Criteria

A. Confirmed case

- Pleocytosis in cerebrospinal fluid, AND
 - Evidence of intrathecal production of Lyme borreliosis antibodies, OR
 - *Borrelia burgdorferi* s.l. isolation, OR
 - nucleic acid detection in cerebrospinal fluid
- OR
- Detection of IgG Lyme borreliosis antibodies in blood specimen only for children (age under 18) with facial palsy or other cranial neuritis and a recent (< 2 months) history of erythema migrans

B. Probable case

- Pleocytosis in cerebrospinal fluid AND positive Lyme borreliosis serology in cerebrospinal fluid
- OR
- Specific intrathecal Lyme borreliosis antibody production

Epidemiological Criteria

Not applicable

Case Classification

A. Possible case

Not applicable

B. Probable case

Any person meeting the clinical criteria and at least one of the laboratory criteria for probable cases

C. Confirmed case

Any person meeting the clinical criteria and at least one of the laboratory criteria for confirmed cases

Tekenencefalitis

Bron: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/ 945 - of 22 June 2018 - on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant case definitions (europa.eu)

3.46. TICK-BORNE VIRAL ENCEPHALITIS

Clinical Criteria

Any person with symptoms of inflammation of the CNS (for example, meningitis, meningo-encephalitis, encephalomyelitis, encephaloradiculitis)

Laboratory Criteria ⁽¹⁾

Laboratory criteria for case confirmation:

At least one of the following five:

- TBE specific IgM AND IgG antibodies in blood
- TBE specific IgM antibodies in CSF
- Seroconversion or four-fold increase of TBE-specific antibodies in paired serum samples
- Detection of TBE viral nucleic acid in a clinical specimen,
- Isolation of TBE virus from clinical specimen

Laboratory criteria for a probable case:

Detection of TBE-specific IgM-antibodies in a unique serum sample

Epidemiological Criteria

Exposure to a common source (unpasteurised dairy products)

Case Classification

A. Possible case NA

B. Probable case

Any person meeting the clinical criteria and the laboratory criteria for a probable case,

OR

Any person meeting the clinical criteria with an epidemiological link

C. Confirmed case

Any person meeting the clinical and laboratory criteria for case confirmation

Note: Serological results should be interpreted according to previous exposure to other flaviviral infections and the flavivirus vaccination status. Confirmed cases in such situations should be validated by serum neutralization assay or other equivalent assays.

Acute slappe verlamming

Bron : <https://www.sciensano.be/nl/surveillance-van-infectieziekten-bij-kinderen-pedisurv>

▼ Acute slappe verlamming (ASV)

Acuut klinisch beeld van focale slapheid of verlamming met verminderde tonus zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (zoals een trauma), bij kinderen < 15 jaar.

- Gelieve 2 stoelgangstalen af te nemen voor het uitsluiten van een enterovirus infectie.

Mogelijke oorzaken:

- Acute anterior poliomyelitis door een poliovirus of een ander neurotroop virus (coxsachie virus, echovirus...)
- Acute myelopathie: idiopathisch, paraspinaal abces, tumor of hematoom
- Perifere neuropathie:
 - Syndroom van Guillain-Barré
 - Acute demyeliniserende neuropathie
 - Acute axonale neuropathie
 - Post-rabies vaccin
 - Neuropathie door infectieziekten (difterie, Lyme borreliose...) of intoxicaties
- Systeemziekten: acute intermitterende porfyrurie
- Stoornis van de neuromusculaire transmissie: myasthenia gravis, botulisme
- Spieraandoeningen: idiopathische inflammatoire myopathie (polymyositis), trichinosis, hypokaliemische en hyperkaliemische paralyse

CONTACT

Contactpersoon: Giulietta Stefani • T+32 2 642 55 00 • neurosurv@sciensano.be

OVER SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn.

Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

MEER INFO

Sciensano.be – info@sciensano.be

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11